

Notes d'examen

Date 19 / 11 /23

- **Le caryotype est réalisé** : pendant la métaphase /correspond au dénombrement et à l'identification de tous les K d'une cellule
- **Les K qui peuvent être impliqués dans les translocations robertsoniennes**: les K acrocentriques donc 13 14 15 21 et 22
- **Concernant l'amniocentèse** : Permet de récupérer les cellules fœtales , permet de réaliser le caryotype du fœtus , nécessite 2 à 3 semaines pour répondre un résultat du caryotype
- **Une translocation** : correspond à un échange de segments distaux entre 2 K , résulte de 2 cassures sur 2 K différents
- **Dans une maladie récessive liée à l'X** : les femmes hétérozygotes ne sont pas malades mais peuvent transmettre la maladie , Une fille sur deux est conductrice , Habituellement la maladie ne se manifeste que chez les sujets de sexe masculin
- **Une translocation robertsonienne** : a lieu entre les K acrocentriques , donne un phénotype normal , donne des conséquences méiotiques, correspond à une fusion centromériques entre 2 K acrocentriques
- **Dans une maladie autosomique récessive** : les hétérozygotes sont sains , la maladie ne s'exprime que chez les homozygotes
- **Une translocation réciproque** : peut se déséquilibrer lors de la méiose , donne un phénotype anormal lorsqu'il y a cassure d'un gène , peut résulter d'un accident méiotique
- **La triploidie** : correspond à 3 copies de chaque K , correspond à 69 K , peut résulter d'une anomalie de la fécondation
- **Pour réaliser un caryotype**: différents types de prélèvement peuvent être utilisés , on peut utiliser des agents mitogènes pour stimuler la croissance cellulaire
- **Les anomalies de structure qui correspondent à un état de déséquilibre du génome sont** : les duplications , les isochromosomes , les délétions , les K en anneau

Notes

Date / /

- **Concernant l'hybridation in situ en fluorescence** : elle est basée sur la capacité de l'ADN à se dénaturer et renaturer , elle permet la recherche d'un syndrome microdélétionnel connu après orientation clinique , elle permet d'analyser des régions sur les K d'une cellule en métaphase
- **La CGH Array** : est 100 à 1000 fois plus résolutive que le caryotype classique
- **A propos des anomalies chromosomiques**: Les remaniements constitutionnelles peuvent se former lors des premières divisions embryonnaires . Les anomalies de nombre peuvent résulter d'une anomalie de la fécondation . Les anomalies de structure impliquent une ou plusieurs cassures chromosomiques suivies d'un recollement anormal
Au moins 1% des naissances sont porteuses des anomalies chromosomiques. La majorité des fausses couches précoces sont dues à une anomalie chromosomique
- **Les anomalies qui portent sur un seul K sont** : Isochromosome , Délétion interstitielle , K en anneau et Inversion paracentrique
- **L'ordre correct pour obtenir un caryotype métaphasique analysable**: Blocage des divisions cellulaires en mitose, choc hypotonique , fixation des préparations chromosomiques , étalement sur lames, dénaturation (thermique ou enzymatiques) , et coloration au GIEMSA